



Troubles bipolaires et anorexie mentale : une étude clinique

M. Valentin, L. Radon, J. Duclos, F. Curt, N. Godart

► To cite this version:

M. Valentin, L. Radon, J. Duclos, F. Curt, N. Godart. Troubles bipolaires et anorexie mentale : une étude clinique. L'Encéphale, 2019, 45, pp.27 - 33. 10.1016/j.encep.2017.10.005 . hal-03486808

HAL Id: hal-03486808

<https://hal.science/hal-03486808v1>

Submitted on 20 Dec 2021

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.



Distributed under a Creative Commons Attribution - NonCommercial 4.0 International License

Troubles bipolaires et anorexie mentale: une étude clinique

Bipolar disorders and Anorexia Nervosa: a clinical study

Marie Valentin ^{a*}, Leslie Radon ^{b,d,e*}, Jeanne Duclos ^b, Florence Curt ^b, Nathalie Godart ^{a,b,c}

** Co-premiers auteurs*

^a Centre Hospitalier Argenteuil, 69 rue du Lieutenant Colonel Prudhon, 95100 Argenteuil, France

^bDépartement de psychiatrie, Institut Mutualiste Montsouris (IMM), 42 boulevard Jourdan, 75014 Paris, France

^cFaculté de Médecine, Université Paris Descartes, 15 rue de l'Ecole de Médecine, 75006 Paris, France

^d UVSQ, CESP, Inserm, Université Paris-Saclay, Université Paris Sud, Villejuif, France

^e Nightingale Hospitals Paris - Clinique du Château de Garches, 11 bis rue de la Porte Jaune, 92380 Garches, France

Auteur correspondant : Leslie Radon

Département de Psychiatrie, Institut Mutualiste Montsouris, 42 boulevard Jourdan, 75014 Paris, France. Tel: 33 1 56 61 69 35. Fax: 33 1 56 61 69 34. E-mail: leslie.radon@imm.fr

CONFLITS D'INTERETS

Les auteurs déclarent ne pas avoir de liens d'intérêts.

TROUBLES BIPOLAIRES ET ANOREXIE MENTALE : UNE ÉTUDE CLINIQUE

BIPOLAR DISORDERS AND ANOREXIA NERVOSA: A CLINICAL STUDY

RESUME

Contexte : L'anorexie Mentale (AM) présente fréquemment des comorbidités avec les troubles de l'humeur, en particulier la dépression, par contre les antécédents individuels et/ou familiaux de troubles bipolaires (BP) a quant à lui été peu étudié. **Objectifs :** Cette étude a pour objectifs (1) d'évaluer, d'une part, la fréquence des troubles bipolaires auprès de patients souffrant d'anorexie mentale hospitalisés à l'adolescence et leurs parents ; (2) et d'autre part, de rechercher si les patientes aux antécédents personnels et/ou familiaux de trouble bipolaire présentent des caractéristiques particulières quant à l'expression clinique de leur anorexie mentale, leurs antécédents, les diagnostics secondaires posés, les traitements prescrits. **Méthode :** 97 patientes, âgées entre 13 et 20 ans, hospitalisées pour anorexie mentale ont été évaluées. Les diagnostics anorexie mentale et trouble bipolaire ont été posés selon les critères du DSM IV-TR. **Résultats :** Une fréquence élevée de troubles bipolaires de type II et de type V a été observée. Les patientes souffrant d'anorexie mentale et présentant des antécédents personnels ou familiaux de trouble bipolaire ont un début plus précoce de l'anorexie mentale, un nombre d'hospitalisations plus important, un délai plus long entre le début de l'anorexie mentale et l'hospitalisation un nombre plus élevé de tentatives de suicide, et présentent davantage de comorbidités psychiatriques. **Conclusion :** La présence d'une comorbidité anorexie mentale-trouble bipolaire semble importante et liée à la sévérité de l'anorexie mentale.

Mots-clés : Troubles des conduites alimentaires anorexie mentale, troubles bipolaires, antécédents familiaux.

ABSTRACT

Purpose: Anorexia Nervosa is often accompanied by comorbid mood disorders, in particular depression, but individual or family history of bipolar disorders has not frequently been explored in anorexia nervosa. The objectives of the present study were 1) to assess the frequency of bipolar disorders in patients with anorexia nervosa hospitalized in adolescence and in their parents, 2) to determine whether the patients with a personal or family history of bipolar disorders present particular characteristics in the way in which anorexia nervosa manifests itself, in their medical history, in the secondary diagnoses established, and in the treatments prescribed. **Method:** 97 female patients aged 13 to 20 hospitalized for anorexia nervosa and their parents were

assessed. The diagnoses of anorexia nervosa and bipolar disorders were established on the basis of DSM-IV-TR criteria. **Results:** A high frequency of type II and type V bipolar disorders was observed. The patients with anorexia nervosa and presenting personal or family histories of bipolar disorder had an earlier onset of anorexia nervosa, more numerous hospitalizations, a longer time-lapse between anorexia nervosa onset and hospitalization, more suicide attempts and more psychiatric comorbidities. **Conclusion:** The occurrence of anorexia nervosa-bipolar disorders comorbidity appears to be considerable and linked to the severity of anorexia nervosa, raising the issue of the relationship between anorexia nervosa and bipolar disorders.

Key words:

Eating disorders, anorexia nervosa, bipolar disorders, comorbidity, family history.

ABREVIATIONS

TCA: Troubles des Conduites Alimentaires

AM: Anorexie Mentale

BN: Boulimie Nerveuse

BP: Trouble Bipolaire

BP-I: Trouble Bipolaire type I

BP-II: Trouble Bipolaire type II

BP-V: Trouble Bipolaire type V

EDM: Episode Dépressif Majeur

TDM: Trouble Dépressif Majeur

IMC: Indice de Masse Corporelle

SPSS: Statistical Package for Social Sciences

INTRODUCTION

L'anorexie mentale (AM) est une pathologie sévère associée à de nombreuses comorbidités [1]. Dès les années 80, certains auteurs ont questionné une comorbidité possible avec les troubles bipolaires (BP) en particulier à l'adolescence [2, 3]. De la même manière, la fréquence des troubles des conduites alimentaires est également élevée chez les patients souffrant de trouble bipolaire [4, 5, 6]. Cependant, l'évaluation de la fréquence d'apparition de trouble bipolaire au sein de population de patients souffrant d'anorexie mentale n'a été que très peu réalisée et le lien entre ces deux troubles ne demeure que trop peu abordé dans la littérature.

Alors que la prévalence sur la vie entière d'au moins un trouble de l'humeur est importante et a été fréquemment étudiée -elle varie entre 64,1 % et 96 % parmi les sujets souffrant d'anorexie mentale [1], soit significativement plus fréquente qu'en population générale féminine où elle est de 17 % [7]. La prévalence des troubles bipolaires de type II quant à elle est bien plus faible, et ce, également en population générale féminine (0,4 %) [8]. Dans la population générale, Hudson *et coll* [9] ont retrouvé une prévalence d'anorexie mentale de 0,6 % et une prévalence de trouble bipolaire de 3 % chez les anorexiques mentales chez 9 282 sujets de plus de 18 ans aux USA.

Les études concernant la comorbidité « trouble bipolaire-anorexie mentale » sont rares : trois chez des anorexiques mentales actuelles [10, 11, 12] et trois études de devenir [13, 14, 15]. La fréquence des troubles bipolaires sur la vie varie selon les études entre 0 % auprès de 14, 21 et 62 patientes souffrant d'AM-R [10, 11, 12], chez des AM-R et 6 % chez des 36 patientes souffrant d'anorexie mentale-trouble bipolaire [12]. Dans les études de devenir, les prévalences actuelles de troubles bipolaires varient entre 0 % chez 51 patientes initialement suivies en ambulatoire après 6,7 ans de suivi [14] prévalence qui augmente avec le temps puisqu'elle atteint 1,9 % après 10 ans de suivi au sein du même échantillon [15] et 3,2 % parmi 62 patientes souffrant d'anorexie mentale ayant été hospitalisées 10 ans auparavant, significativement plus que le groupe contrôle (0 %) [13]. En ce qui concerne les prévalences de troubles bipolaires sur la vie dans l'anorexie mentale, celles-ci varient entre 3,2 % parmi 62 femmes hospitalisées 10 ans auparavant pour anorexie mentale, significativement plus que le groupe contrôle (0 %) [13], et 5,8 % chez 51 femmes suivies 10 ans auparavant en ambulatoire [15].

Par ailleurs, Campos *et al.* [16]. ont quant à eux souligné une prévalence importante (68,1 %) de troubles du spectre bipolaire auprès de 69 patientes adultes souffrant de troubles des conduites alimentaires hospitalisées dans un centre tertiaire. Ces auteurs rapportent également que les sujets présentant à la fois un trouble bipolaire et un trouble des conduites alimentaires souffriraient également plus d'un trouble de consommation de substances (40,4 %) par rapport aux patients souffrant de troubles des conduites alimentaires sans trouble bipolaire (13,6 %) (OR = 4,298; P = 0,03).

Par ailleurs, très peu de travaux se sont intéressés à l'étude conjointe des antécédents familiaux de troubles bipolaires dans l'anorexie mentale chez les patients hospitalisés ou suivis en ambulatoire pour lequel on recherche des troubles bipolaires. Récemment, une étude familiale a rapporté que la présence d'antécédents familiaux de trouble bipolaire augmentait le risque de développer un trouble des conduites alimentaires, en particulier une anorexie mentale chez leurs enfants [17].

Ainsi, il existe des arguments pour penser que le trouble bipolaire est très fréquent chez les patients souffrant de trouble des conduites alimentaires, et ce, en particulier les formes sévères traitées dans les centres tertiaires. Toutefois, peu d'études récentes ont évalué la prévalence des troubles bipolaires chez les patients souffrant d'anorexie mentale sévère à l'adolescence. Or, l'intrication de ces deux troubles est considérée comme un facteur de gravité assombrissant le pronostic du trouble alimentaire et possiblement aussi celui du trouble bipolaire [18]. Les troubles anorexiques se déclarant fréquemment avant 18 ans, dépister les troubles bipolaires chez ces patientes permettrait de débiter plus précocement le traitement de ces derniers et permettant ainsi possiblement l'amélioration du pronostic des deux troubles. De même, très peu de travaux se sont intéressés à l'étude des antécédents familiaux de trouble bipolaire dans l'anorexie mentale chez les patients hospitalisés ou suivis en ambulatoire.

Par conséquent, la présente étude en population clinique d'adolescents souffrant d'anorexie mentale a pour objectifs (1) d'une part, d'évaluer la fréquence des troubles bipolaires chez des patients souffrant d'anorexie mentale sévère ayant nécessité une hospitalisation à l'adolescence et dans leur famille ; (2) et d'autre part, de rechercher si les patientes aux antécédents personnels et/ou familiaux de trouble bipolaire présentent des caractéristiques particulières quant à l'expression clinique de leur anorexie mentale, leurs antécédents, les diagnostics secondaires posés, les traitements prescrits.

MÉTHODOLOGIE

Recrutement et Procédure d'évaluation

Il s'agit d'une étude d'observation portant sur les 118 dossiers des patientes sorties d'hospitalisation pour anorexie mentale dans le service de psychiatrie de l'adolescent et du jeune adulte de l'Institut Mutualiste Montsouris (Paris) sur une période de trois ans (entre le 1^{er} janvier 2006 et le 31 décembre 2008). Ce service est spécialisé dans la prise en charge des troubles des conduites alimentaires. Il reçoit des adolescents venant principalement de Paris et de la région parisienne, dont l'âge est compris entre 13 et 20 ans [19,20].

14 sujets ont été hospitalisés deux fois et un sujet a été hospitalisé trois fois sur cette période. Ces 18 dossiers ont été exclus. Du fait du très petit nombre de patients concernés (deux) et de leurs caractéristiques cliniques différentes (l'un des deux patients présentait un antécédent de craniopharyngiome), deux garçons ont été exclus.

Quatre dossiers ont été si incomplets qu'ils n'ont pu être utilisés. Au total, 96 dossiers correspondant à 96 patientes souffrant d'anorexie mentale ont été inclus.

Procédure

Les patients ont été évalués pendant leur hospitalisation, lors d'entretiens cliniques individuels des psychiatres expérimentés (chefs de clinique ou praticiens hospitaliers) référents pour ces patients. Les parents ont été évalués directement lors d'entretiens familiaux par des psychiatres expérimentés. Les diagnostics des apparentés autres que les parents ont été établis à l'aide du questionnaire anamnestique de façon indirecte (informations recueillies auprès des parents).

Dossier clinique standardisé

Les données cliniques concernant les variables étudiées sont extraites d'un dossier clinique standardisé rempli pour tous les patients hospitalisés dans le service. Ce dossier se compose de deux parties [5, 21].

La première partie est remplie pour tous les patients et rassemble les informations suivantes :

- motif d'hospitalisation et diagnostic(s) à la sortie
- caractéristiques sociodémographiques d'après le questionnaire utilisé par l'INSERM dans son protocole de recherche sur la dépendance [22].
- antécédents personnels et familiaux, recueillis d'après le questionnaire anamnestique expérimental inspiré des fiches anamnestiques du système AMDP (association pour la méthodologie et la documentation en psychiatrie) selon DSM-IV.

La seconde partie du dossier ne concerne que les patients ayant des troubles des conduites alimentaires. Elle comprend :

- la recherche des critères DSM IV pour l'anorexie mentale, la boulimie et le trouble des conduites alimentaires non spécifié
- les antécédents pondéraux des patients (âge de début des troubles, IMC minimal et maximal, durée de l'aménorrhée, utilisation d'une contraception hormonale)

Les données utilisées plus particulièrement pour cette étude sont :

- les caractéristiques de l'hospitalisation (âge à l'admission, IMC à l'admission et à la sortie du service, IMC de sortie de séparation et de sortie définitive définis par le contrat de poids, durée d'hospitalisation, pose d'une sonde naso-gastrique pour renutrition entérale (si oui, combien de fois et combien de temps), traitement à la sortie, nécessité d'une prise en charge en réanimation)

- les caractéristiques de l'anorexie mentale (type restrictif ou purgatif, âge de début des troubles, durée d'évolution, IMC minimal et maximal, âge de début du suivi et délai par rapport à l'hospitalisation, nombre d'hospitalisations antérieures)

- les antécédents psychiatriques des sujets (épisode dépressif, tentative de suicide, consommation de haschisch, fugues, séparation précoce d'avec la mère et troubles de la petite enfance tels que retard psychomoteur, énurésie, encoprésie, anorexie, mérycisme)

les antécédents psychiatriques familiaux (père, mère, frères et sœurs)

Constitution des groupes

Afin de comparer les patientes souffrant d'anorexie mentale présentant une histoire personnelle et/ou familiale de trouble bipolaire avec les autres patientes souffrant d'anorexie mentale, les 96 patientes constituant l'échantillon de cette étude seront réparties en deux groupes (figure 1) :

Le premier groupe a été constitué des patientes présentant à la fois une histoire personnelle d'épisode dépressif et/ou mélancolique et/ou hypomaniaque et des antécédents familiaux de trouble bipolaire avérés ou suspectés. Les patientes ayant présenté un épisode dépressif ou mélancolique et un épisode hypomaniaque peuvent être classées dans le trouble bipolaire de type II. Les patientes ayant présenté un épisode dépressif ou mélancolique et des antécédents familiaux de trouble bipolaire peuvent être classées dans le trouble bipolaire de type V [23].

Le second groupe a été constitué par les autres patientes, sans antécédents personnels ou familiaux identifiés de trouble bipolaire.

FIGURE 1.

Analyses statistiques

Les données ont été collectées et analysées au moyen du logiciel SPSS (*Statistical Package for Social Science*) version 20.0. Chaque variable quantitative a été décrite à partir de la moyenne, la médiane, l'écart type, le minimum, le maximum. Les comparaisons statistiques ont été effectuées au moyen du test non paramétrique de Mann-Whitney du fait d'effectifs inférieurs à 30 dans les groupes étudiés. Les variables qualitatives ont été déterminées à partir des fréquences de distribution et de leur comparaison au moyen du test du khi-deux, en utilisant le test exact de Fisher lorsque l'effectif théorique minimum est inférieur à 5. Le seuil de significativité statistique utilisé est $\alpha = 0,05$. Des analyses multivariées ont été réalisées (régression logistique) pour ajuster les variables concernant des IMC par rapport à l'âge des sujets, mais aussi pour rechercher des liens entre les différentes variables et les antécédents de bipolarité.

RÉSULTATS

Les 96 sujets constituant l'échantillon de cette étude sont issus de catégories socioprofessionnelles plutôt favorisées : dans 47,4 % des cas le père exerce une profession de cadre ou dite intellectuelle supérieure, ainsi que la mère dans 31,6 % des cas. De même, le père exerce une profession intermédiaire dans 20 % des cas, ainsi que la mère dans 22,1 % des cas. Seuls 3,2 % des sujets ont un père sans activité professionnelle (17,9 % d'inactivité pour la mère).

Les données cliniques concernant l'hospitalisation sont rapportées dans le tableau 2. Les patientes de l'échantillon sont en moyenne hospitalisées à l'âge de 16,5 ans $\pm$ 1,7, avec un IMC à l'admission de 14,2 $\pm$ 1,2. Le début de l'anorexie mentale chez les sujets de notre échantillon a débuté en moyenne à 14,5 ans $\pm$ 1,8, soit 2,0 ans $\pm$ 1,7 avant leur hospitalisation. Il s'agit d'une AM-R dans 67,7 % des cas. Le nombre moyen d'hospitalisations antérieures pour anorexie mentale est de 0,8 $\pm$ 1,5.

La présence ou un antécédent d'épisode dépressif majeur est relevé chez 46,8 % des patientes et le nombre moyen de tentatives de suicide est de 0,22 $\pm$ 0,7. Par ailleurs, 4,2 % des sujets consomment du haschisch de manière ponctuelle et 2,1 % de manière régulière. Un antécédent de fugue à l'adolescence est retrouvé chez 8,4 % des patientes. Des troubles de la petite enfance (retard psychomoteur, énurésie, encoprésie, anorexie, mérycisme) sont rapportés pour 16,7 % des patientes et une séparation précoce avec la mère pour 13,7 % des sujets.

Le tableau 1 montre que 6,3 % des sujets (soit 6 sujets) présentent un trouble bipolaire de type II. De plus, 11 patientes (11,5 %) présentent un trouble bipolaire subsyndromique de type V, c'est-à-dire un épisode dépressif ou mélancolique et des antécédents familiaux de trouble bipolaire. Au total, 17,7 % des sujets présentent un trouble appartenant au spectre bipolaire. Le traitement de sortie comprend pour 46,9 % des patientes un antidépresseur, pour 17,7 % un neuroleptique, pour 7,3 % un thymorégulateur, pour 24 % un anxiolytique et pour 6,3 % un hypnotique. Les traitements antidépresseurs sont prescrits dans 6,7 % des cas pour des patientes présentant un trouble obsessionnel compulsif, dans 8,9 % des cas pour des patientes présentant un trouble bipolaire et dans 77,8 % des cas pour des patientes présentant un trouble dépressif.

Sur le plan des antécédents familiaux (voir tableau 3), on retrouve chez les mères des sujets un trouble des conduites alimentaires -c'est-à-dire soit une anorexie mentale soit une boulimie nerveuse- dans 19,8 % des cas, un trouble dépressif majeur dans 53,1 % des cas, un trouble anxieux dans 9,4 % des cas, un trouble de la personnalité dans 8,3 % des cas et un trouble lié à la consommation d'alcool dans 1 % des cas. Par ailleurs, on note chez les pères des sujets aucun trouble des conduites alimentaires, 19,8 % de trouble dépressif majeur, 6,3 % de troubles anxieux, 9,4 % de troubles de personnalité et 14,6 % de troubles liés à la consommation d'alcool. Enfin, dans la fratrie des sujets, on observe 5,2 % de trouble des conduites alimentaires, 19,8 % de trouble dépressif majeur, 6,3 % de troubles anxieux, 9,4 % de troubles de la personnalité et 14,6 % de troubles liés à la consommation d'alcool.

Par ailleurs, nous avons retrouvé un antécédent familial avéré de trouble bipolaire chez 8,3 % des patientes et une forte suspicion auprès de 13,6 % des patientes de notre échantillon.

Par conséquent, les 96 patientes de notre échantillon sont divisées en deux groupes :

Le premier groupe est constitué des 17 patientes présentant à la fois une histoire personnelle d'épisode dépressif et/ou mélancolique et/ou hypomaniaque et des antécédents familiaux de troubles bipolaires avérés ou suspectés

Le second groupe est constitué par les 79 autres patientes, sans antécédents personnels ou familiaux identifiés de trouble bipolaire.

Comparaison des deux groupes

L'âge moyen est comparable dans les deux groupes observés. Les résultats concernant des variables d'IMC ont été ajustés par rapport à l'âge pour tenir compte de l'évolution de la corpulence au cours de la croissance. Après ajustement par rapport à l'âge, les IMC (à l'entrée, à la sortie, minimal et maximal) observés dans les deux groupes n'étaient pas significativement différents.

Histoire et symptômes des sujets

Le tableau 2 présente les données concernant l'histoire et la symptomatologie des sujets. Dans le groupe de sujets (N = 17) présentant une histoire personnelle ou familiale de trouble bipolaire, nous avons retrouvé: une anorexie mentale ayant débuté à un âge plus précoce ($13,4 \text{ ans} \pm 1,7$ en moyenne contre $14,8 \text{ ans} \pm 1,8$; $p=0.005$), des délais entre le début de l'anorexie mentale et l'hospitalisation ($3,4 \text{ ans} \pm 2,3$ contre $1,7 \text{ an} \pm 1,4$; $p = 0.004$), un nombre d'hospitalisations antérieures pour anorexie mentale plus élevé ($1,7 \pm 2,4$ en moyenne contre $0,6 \pm 1,2$; $p = 0,03$), des antécédents de dépression nettement plus importants (100 % contre 46,8 % ; $p < 0,001$), un nombre significativement plus élevé de tentatives de suicide ($0,8 \pm 1,5$ en moyenne contre $0,1 \pm 0,4$; $p = 0,003$), une renutrition entérale par sonde naso-gastrique pendant leur hospitalisation (81,3 % des sujets contre 45,5 % ; $p = 0,009$), un traitement par thymorégulateur à leur sortie (35,3 % des patients contre 1,3 % ; $p<0,001$).

Antécédents familiaux

En ce qui concerne les antécédents familiaux (voir le tableau 3), aucune différence statistiquement significative n'est observée entre les deux groupes. Toutefois, les troubles liés à la consommation d'alcool ont tendance à être moins souvent retrouvés parmi les pères et la fratrie des sujets du groupe présentant une histoire personnelle ou familiale de trouble bipolaire (N = 17).

DISCUSSION

La prévalence des troubles bipolaires observée dans notre échantillon de patientes présentant une anorexie mentale sévère (c'est-à-dire conduisant à une hospitalisation dans un centre spécialisé dans la prise en charge des troubles des conduites alimentaires) est élevée. En effet, 17,7 % des sujets anorexie mentale présentent un trouble appartenant au spectre bipolaire contre 0.4 % en population générale féminine [8]. Les patientes souffrant d'anorexies mentales sévères pour lesquelles il existe une histoire d'antécédents individuels ou familiaux de trouble bipolaire souffrent d'une forme de trouble des conduites alimentaires plus sévère associée à : un début d'anorexie mentale plus précoce (14 ans contre 14,6 ans), un délai plus long entre le début de l'anorexie mentale et l'hospitalisation (3,4 ans contre 1,7 an),

un nombre plus élevé d'hospitalisations antérieures pour anorexie mentale (1,7 contre 0,6), une renutrition entérale par sonde naso-gastrique pendant l'hospitalisation (81,3 % contre 45,5 %) plus fréquente, un nombre plus élevé de tentative de suicide (0,8 contre 0,1), une prévalence d'épisode dépressif majeur plus importante (100 % contre 46,8 %), et un traitement par thymorégulateur plus fréquent (35,3 % contre 1,3 %). Toutefois, nous n'avons retrouvé aucune différence en termes de fréquence d'antécédents familiaux entre les deux groupes de patientes (avec antécédents individuels ou familiaux de trouble bipolaire versus aucun antécédent de trouble bipolaire) mais notre échantillon est relativement restreint.

Nous avons retrouvé une fréquence élevée de trouble bipolaire (17,8 %) auprès de patientes adolescentes souffrant d'anorexie mentale sévère : 6,3 % des sujets présentent un trouble bipolaire de type II et 11,5 % présentent un trouble bipolaire subsyndromique de type V, c'est-à-dire un épisode dépressif ou mélancolique et des antécédents familiaux de trouble bipolaire. Cette prévalence est globalement plus élevée que celle rapportée dans la plupart des études [24, 25]. La différence observée pourrait s'expliquer en partie, d'une part, par l'usage de différentes définitions de trouble bipolaire et, d'autre part, par le fait que nous avons ciblé un échantillon plus homogène que dans les autres études, incluant des sujets présentant une anorexie mentale particulièrement sévère. En effet, il a été observé que l'accès à un niveau de soins plus intensifs sélectionne, notamment dans l'anorexie mentale, les sujets de plus grande gravité avec des comorbidités, en particulier dépressives, plus importantes [1].

Nous avons mis en évidence certains éléments de gravité chez les patientes souffrant d'anorexie mentale sévère pour lesquelles il existe une histoire d'antécédents individuels ou familiaux de trouble bipolaire. Cela pourrait s'expliquer par la plus grande durée d'évolution de l'anorexie mentale et/ou par une anorexie mentale plus sévère. En faveur de cette dernière hypothèse, on observe que ces patientes nécessitent plus souvent au cours de leur hospitalisation une renutrition entérale par sonde nasogastrique, ce qui suggère qu'elles arrivent dans un état somatique plus précaire.

Sur le plan des antécédents familiaux, une étude récente auprès de 158, 679 enfants a montré que le risque de développer un trouble des conduites alimentaires était accru en présence d'antécédents familiaux de trouble bipolaire, de troubles dépressifs ou encore de troubles de la personnalité [17]. À l'inverse, la relation comorbide « anorexie mentale-dépression » chez les femmes augmenterait le risque de présenter une psychopathologie chez leurs enfants [26]. Toutefois le trouble bipolaire demeure mal connu et le retard au diagnostic est fréquent : un délai moyen de 10 ans est rapporté entre le début des troubles et l'instauration d'un traitement approprié [27]. Par conséquent, en cas d'antécédents familiaux de trouble bipolaire, un début précoce de l'anorexie mentale peut alerter le clinicien sur la possibilité d'un début masqué d'un tel trouble.

Les tentatives de suicide et les suicides sont très fréquents dans l'anorexie mentale [28]. On constate que les patientes souffrant d'anorexie mentale présentent un nombre plus important de tentatives de suicide que les patientes sans antécédents de trouble bipolaire, ce qui est cohérent avec les données actuelles soulignant la fréquence

élevée de tentative de suicide chez les sujets souffrant de trouble bipolaire et la nécessité de leur dépistage précoce [16, 29, 30].

Sur le plan des comorbidités, les patientes avec une histoire personnelle et/ou familiale de bipolarité ont toutes présenté au moins un épisode dépressif majeur au cours de leur vie, soit significativement plus que celles de l'autre groupe. Les résultats de notre étude mettent en avant la fréquence élevée d'épisode dépressif majeur précoce chez ces adolescentes. La survenue d'un tel épisode dépressif majeur doit alerter le clinicien sur la possibilité d'un développement d'un trouble bipolaire. En effet, comme l'a souligné Akiskal [31], la survenue d'un épisode dépressif majeur avant l'âge de 20 ans témoigne d'un risque accru de développer un trouble bipolaire par la suite. Ainsi, 25 % des enfants ou adolescents qui présentent un épisode dépressif majeur développent un trouble bipolaire dans les 2 à 5 ans suivants [31]. Par conséquent, la survenue ou la présence d'antécédents d'un trouble dépressif, chez une patiente souffrant d'anorexie mentale peut alerter sur le risque de développement d'un trouble bipolaire.

Ces résultats soulèvent la question du lien entre anorexie mentale et trouble bipolaire. McElroy et al. [5] proposent deux explications de cette comorbidité: (1) les troubles des conduites alimentaires et les troubles bipolaires sont deux entités distinctes ou bien partageant des mécanismes étiologiques mais représentant chacune un risque pour l'autre ; (2) les troubles des conduites alimentaires et trouble bipolaire partagent de nombreuses caractéristiques comme, la pathophysiologie de dérégulation de l'humeur, le comportement alimentaire et le contrôle, ce qui s'appuie sur les résultats des études montrant une association significative entre épisodes dépressifs et antécédents familiaux de trouble bipolaire [5, 6, 16, 32]. Ainsi, cela questionne la place de la prescription des traitements thymorégulateurs chez les patientes souffrant d'anorexie mentale. En effet, si l'épisode anorexique peut être considéré comme un début de trouble bipolaire, alors la survenue, par exemple, d'un épisode hypomaniaque dans ce contexte pourrait justifier de la mise en place d'un traitement thymorégulateur comme s'il s'agissait d'un trouble bipolaire de type II. Cette question nécessite toutefois une grande prudence, en l'absence d'études réalisées sur ce sujet.

Actuellement, il n'existe pas de recommandations concernant la prise en charge thérapeutique des patients présentant à la fois une anorexie mentale et un trouble bipolaire. Néanmoins, au vu des résultats de cette présente étude et de la littérature, le clinicien doit se montrer particulièrement vigilant quant au risque de survenue d'un trouble bipolaire chez une patiente souffrant d'anorexie mentale présentant des antécédents familiaux de bipolarité. Comme le soulignent McElroy et al. [5, 6], ce dépistage est d'autant plus crucial que les éléments suivants viennent assombrir le pronostic : risque suicidaire est accru, davantage de comorbidités psychiatriques et d'épisodes maniaques, hypomaniaques et dépressifs, un début d'apparition du trouble bipolaire plus précoce, et des cycles rapides. Ces mêmes auteurs soulignent en conclusion de leur revue de la littérature [5], que la présence d'un trouble bipolaire comorbide peut être un facteur de résistance au traitement du trouble alimentaire d'un patient. Selon ces auteurs, les éléments pouvant indiquer la présence d'une bipolarité chez un patient présentant un trouble des conduites alimentaires sont les suivants : épisode dépressif à un âge précoce, autre comorbidité de l'axe I à un âge précoce,

réurrences dépressives, activation comportementale ou impulsivité, histoire familiale de bipolarité, mauvaise réponse au traitement habituel des troubles alimentaires. Ces éléments sont cohérents avec les résultats de notre étude.

Limites

L'étude présentée ici comporte cependant certaines limites, devant nous rendre prudent pour la généralisation de ces résultats. Tout d'abord, les patients de cette étude ont été hospitalisés dans un centre tertiaire et présentent de fait une anorexie mentale sévère, n'étant ainsi pas représentatifs de l'ensemble des patients souffrant d'anorexie mentale [1]. En effet, les patients souffrant d'un trouble des conduites alimentaires présentent également de nombreuses comorbidités comme le résultat du « biais de Berkson » [33]. De plus, elle est réalisée sur un petit échantillon, mais plus important que ceux des études antérieures. Il en résulte l'impossibilité de réaliser certaines comparaisons statistiques en raison d'effectifs trop petits, par exemple entre les différentes catégories de troubles bipolaires, ainsi qu'entre les différents degrés de certitude des antécédents familiaux. Ensuite, la constitution des groupes peut être discutable. Elle repose sur les données de la littérature exposées précédemment, suggérant l'intérêt de l'étude du spectre bipolaire, car les formes les plus sévères sont également les plus rares, mais aussi car les formes subsyndromiques sont les plus fréquentes à l'adolescence. Nous n'avons également pas étudié la différence en termes de comorbidité avec le trouble bipolaire selon le sous-groupe d'anorexie mentale : restrictif versus purgatif. Or, le sous-type d'anorexie mentale le plus fortement associé au trouble bipolaire s'avère être l'anorexie mentale type purgatif [12, 34, 35].

Par ailleurs, le recueil des antécédents individuels et familiaux n'a pas été réalisé à partir de questionnaires standardisés des sujets et de leurs apparentés. Les parents ont toutefois été évalués directement, par le biais d'entretiens avec un clinicien et selon les critères du DSM-IV. C'est pourquoi cette étude ne constitue qu'un travail exploratoire préliminaire concernant les liens potentiels entre l'anorexie mentale sévère et les troubles bipolaires. D'autres études plus larges seraient nécessaires pour mieux comprendre ces liens et évaluer notamment le devenir de ces sujets et la meilleure stratégie thérapeutique.

CONCLUSION

En conclusion, il existe chez les patients souffrant d'anorexie mentale sévère à l'adolescence une comorbidité importante et leur intrication semble être un facteur de gravité qui assombrit le pronostic du trouble alimentaire et probablement aussi celui du trouble bipolaire. C'est pourquoi sur le plan clinique, il apparaît indispensable lors de l'évaluation de ces patients de rechercher la co-occurrence de ces deux troubles [18, 32] et de développer une nouvelle recherche afin d'explorer le lien entre l'anorexie mentale et les troubles bipolaires.

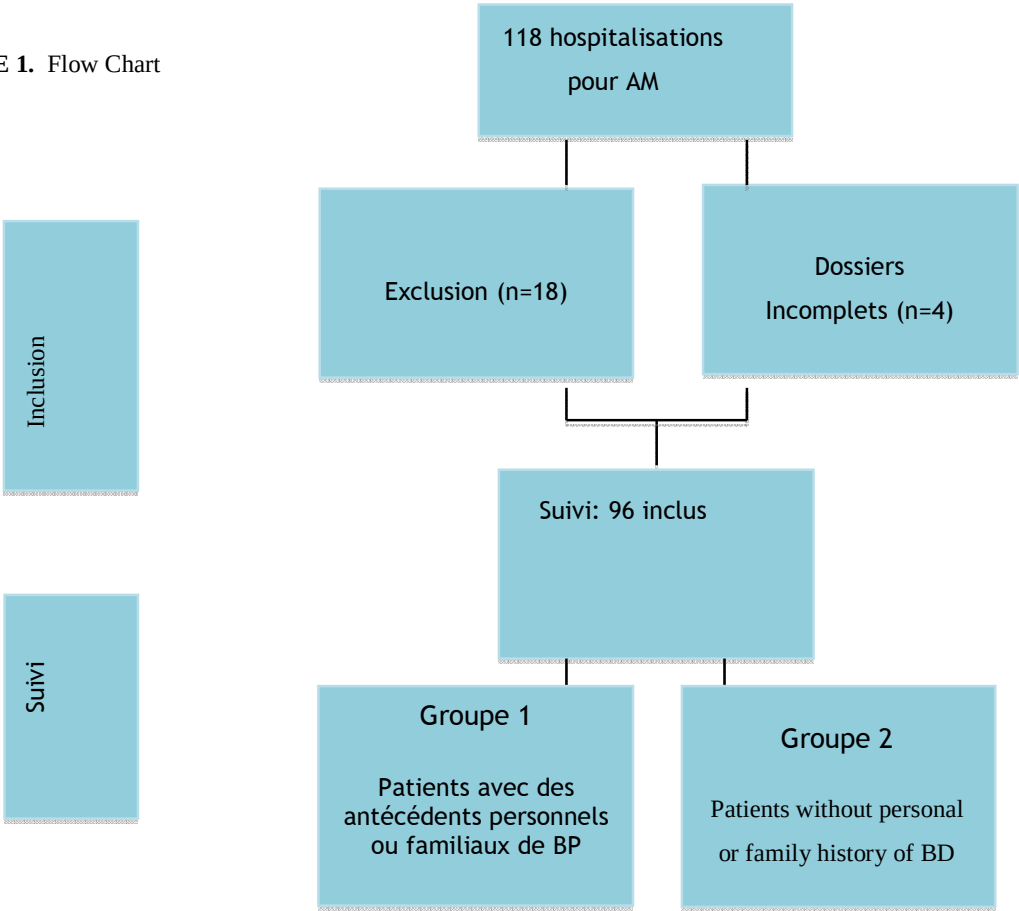
BIBLIOGRAPHIE

1. Godart NT, Perdereau F, Rein Z, Berthoz S, et al. Comorbidity studies of eating disorders and mood disorders. Critical review of the literature. *J Affect Disord* 2007; 97(1-3): 37-49.
2. Ghadirian AM, Steiger H, Leichner PP. A manic episode in the course of anorexia nervosa with bulimia. *Psychosomatics* 1989; 30(1): 101-103
3. Hsu LK, Holder D, Hindmarsh D, et al. Bipolar illness preceded by anorexia nervosa in identical twins. *J Clin Psychiatry* 1984; 45(6): 262-266.
4. Blinder BJ, Cumella EJ, Sanathara VA. Psychiatric comorbidities of female inpatients with eating disorders. *Psychosom Med* 2006; 68(3): 454-462.
5. McElroy SL, Kotwal R, Keck PE. Comorbidity of bipolar and eating disorders: distinct or related disorders with shared dysregulations? *J Affect Disord* 2005; 86(2-3): 107-127.
6. McElroy SL, Frye MA, Helleman G, et al. Prevalence and correlates of eating disorders in 875 patients with bipolar disorder. *J Affect Disord* 2011; 128(3): 191-198.
7. Waraich P, Goldner EM, Somers JM et al. Prevalence and incidence studies of mood disorders : a systematic review of the literature. *Can J Psychiatry* 2004; 49(2): 124-138.
8. Merikangas KR, Jin R, He JP, et al. Prevalence and correlates of bipolar spectrum disorder in the world mental health survey initiative. *Arch. Gen Psychiatry* 2011; 68(3): 241-251.
9. Hudson JI, Hiripi E, Pope JR HG, et al. The prevalence and correlates of eating disorders in the national Comorbidity Survey Replication. *Biol Psychiatry* 2007; 61(3): 348-358.
10. Piran N, Kennedy S, Garfinkel PE et al. Affective disturbance in eating disorders. *J Nerv Ment Dis* 1985; 173(7): 395-400.
11. Laessle RG, Wittchen HU, Fichter MM et al. The significance of subgroups of bulimia and anorexia nervosa : lifetime frequency of psychiatric disorders. *Int J Eat Disord* 1989; 8(5): 569-574.
12. Iwasaki Y, Matsunaga H, Kiriike N, et al. Comorbidity of axis I disorders among eating-disordered subjects in Japan. *Compr. Psychiatry* 2000; 41: 454-460.
13. Ivarsson T, Rastam M, Wentz E, et al. Depressive disorders in teenage-onset anorexia nervosa: A controlled longitudinal, partly community-based study. *Compr Psychiatry* 2000; 41: 398-403.
14. Halmi KA, Eckert E, Marchi P, et al. Comorbidity of psychiatric diagnoses in anorexia nervosa. *Arch Gen Psychiatry* 1991; 48(8): 712-718.

15. Rastam M. Anorexia nervosa in 51 Swedish adolescents: premorbid problems and comorbidity. *J Am Acad Child Adolesc Psychiatry* 1992; 31: 819-829.
16. Campos RN, Dos Santos DJ, Cordas TA. Occurrence of bipolar spectrum disorder and comorbidities in women with eating disorders. *Int J Bipolar Disord* 2013; doi: 10.1186/2194-7511-1-25.
17. Bould H, Koupil I, Dalman C, et al. Parental mental illness and eating disorders in offspring. *Int J Eat Disord* 2013; 48(4): 383-391.
18. Mury M, Verdoux H, Bourgeois M. Comorbidity of bipolar and eating disorders. Epidemiologic and therapeutic aspects. *L'Encephale* 1995; 21: 545-553.
19. Godart N, Curt F, Perdereau F, et al. Are anxiety or depressive disorders more frequent among one of the anorexia or bulimia nervosa subtype? *Encephale* 2005; 31: 279-288.
20. Godart N, Wallier J, Hubert T, et al. Determining factors for target weights in an anorexia nervosa inpatient care program for adolescents and young adults: study on the links between theory-based hypotheses and the realities of clinical practice. *Eat. Weight Disord* 2009; 14(4):176-183.
21. Hubert T, Pioggiosi P, Huas C, et al. Drop-out from adolescent and Young adults inpatient treatment for anorexia nervosa. *Psychiatry Res* 2013; 209: 632-7.
22. Godart N, Berthoz S, Rein Z, et al. Does the frequency of anxiety and depressive disorders differ between diagnostic subtypes of anorexia nervosa and bulimia? *Int J Eat Disord* 2006; 39(8): 772-778.
23. Gorwood P. Masques trompeurs et diagnostics différentiels du trouble bipolaire. *Encéphale* 2004; 30(2): 182-193.
24. Godart NT, Perdereau F, Rein Z, et al. Comorbidity studies of eating disorders and mood disorders. Critical review of the literature. *J Affect Disord* 2007; 97(1-3): 37-49.
25. Tseng MC, Chang CH, Chen KY, et al. Prevalence and correlates of bipolar disorders in patients with eating disorders. *J Affect Disord* 2015; 199: 599-606.
26. Micali N, Stahl D, Treasure J, et al. Childhood psychopathology in children of women with eating disorders understanding risk mechanisms. *J Child Psychol Psychiatry* 2014; 55(2): 124-34.
27. Faedda GL, Marangoni C, Serra G, et al. Precursors of bipolar disorders: a systematic literature review of prospective studies. *J Clin Psychiatry* 2015; 76(5): 614-624.
28. Webb RT, Lichtenstein P, Larsson H, et al. Suicide, hospital-presenting suicide attempts, and criminality in bipolar disorder: Examination of risk for Multiple Adverse Outcomes. *J Clin Psychiatry* 2014; 75(8): 809-816.

29. Goodwin FK & Jamison KR, ed. Manic-Depressive illness. Bipolar disorders and recurrent depression. Oxford, Oxford Press; 2007.
30. Miller C, Bauer MS. Excess mortality in bipolar disorders. *Curr Psychiatry Rep.* 2014; 16(11): doi: 10.1007/s11920-014-0499.
31. Akiskal HS. Developmental pathways to bipolarity: are juvenile-onset depressions pre-bipolar. *J Am Acad Child Adolesc Psychiatry* 1995; 34(6): 754–763.
32. Lunde AV, Fasmer OB, Akiskal KK, et al. The relationship of bulimia and anorexia nervosa with bipolar disorder and its temperamental foundations. *J Affect Disord* 2009; 115(3): 309-314.
33. Berkson J. Limitations of the application of fourfold table analysis to hospital data. *Biometrics* 1946; 2: 47–53.
34. Eddy KT, Keel PK, Dorer DJ, et al. Longitudinal comparison of anorexia nervosa subtypes. *Int J Eat Disord* 2002; 31: 191–200.
35. Godart N, Radon L, Curt F, et al. Mood disorders in eating disorder patients: Prevalence and chronology of ONSET. *J Affect Disord* 2015; 185: 115–22.

FIGURE 1. Flow Chart



Antécédents de troubles de l'humeur		Family			
		Antécédents de troubles bipolaires chez parents ou grand-parents, avec thymoregulateur	Forte suspicion de troubles bipolaires	Aucun	Total
Personnel	Episode mélancolique ou dépressif + episode hypomaniaque	2 (2,1 %)	4 (4,2 %)	0 (0 %)	6 (6,3 %)
	Episode mélancolique ou dépressif	5 (5,2 %)	6 (6,3 %)	37 (38,5 %)	48 (50 %)
	Aucun	1 (1 %)	3 (3,1 %)	38 (39,6 %)	42 (43,7 %)
	Total	8 (8,3 %)	13 (13,6 %)	75 (78,1 %)	96 (100 %)

Tableau 1. Distribution des antécédents personnels et familiaux de troubles de l'humeur au sein de l'échantillon

	Echantillon total (N = 96)	Avec antécédents de troubles (N = 17)	Sans antécédents de troubles (N = 79)	p
Age du début de l'AM (années)	14,5 ± 1,8	13,4 ± 1,7	14,8 ± 1,8	0.005
Délais entre début de l'AM et hospitalisation (years)	2,0 ± 1,7	3,4 ± 2,3	1,7 ± 1,4	0.004
Age du début du suivi pour AM	14,9 ± 1,7	14,5 ± 1,6	15,1 ± 1,7	0.09
Délais entre début du suivi pour AM et hospitalisation	1,6 ± 1,4	2,2 ± 1,6	1,4 ± 1,3	0.04
Nombre de précédents hospitalisations pour AM	0,8 ± 1,5	1,7 ± 2,4	0,6 ± 1,2	0.03
Nombre de tentatives de suicide	0,22 ± 0,7	0,8 ± 1,5	0,1 ± 0,4	0,003
Antécédents ou présence d'au moins un épisode dépressif	56,3 %	100 %	46,8 %	< 0.001
Age à la première consultation psychiatrique	14,4 ± 2,9	14,0 ± 2,0	14,6 ± 3,1	0.09
Nutrition entérale pendant l'hospitalisation	51,6 %	81,3 %	45,5 %	0.009
Nombre de fois où la nutrition entérale a été utilisée	35,3 ± 21,5	25,9 ± 23,8	38,5 ± 20,1	0.007
Traitement à la sortie incluant un thymorégulateur	7,3 %	35,3 %	1,3 %	< 0.001

Tableau 2. Comparaison entre les deux groupes en termes de caractéristiques cliniques

Variables étudiées		Echantillon Total (N = 96)	Subjects with a history of bipolar disorder (N = 17)	Subjects without a history of bipolar disorder (N = 79)	p
Antécédents maternels	Tentative de suicide	4,2 %	11,8 %	2,5 %	0.14
	Suicide	1,0 %	5,9 %	0,0 %	0.18
	TCA	19,8 %	29,4 %	17,7 %	0.32
	Dépression	54,2 %	58,8 %	53,2 %	0.67
	Trouble anxieux	9,4 %	5,9 %	10,1 %	1.00
	Trouble de la personnalité	8,3 %	11,8 %	7,6 %	0.63
	Alcoolisme	1,0 %	5,9 %	0,0 %	0.18
Antécédents paternels	Tentative de suicide	1,0 %	0,0 %	1,3 %	1.00
	Suicide	0,0 %	0,0 %	0,0 %	-
	TCA	0,0 %	0,0 %	0,0 %	-
	Dépression	19,8 %	23,5 %	19,0 %	0.74
	Trouble anxieux	6,3 %	5,9 %	6,3 %	1.00
	Trouble de la personnalité	9,4 %	5,9 %	10,1 %	1.00
	Alcoolisme	14,6 %	0,0 %	17,7 %	0.07
Antécédents chez la fratrie	Tentative de suicide	1,0 %	0,0 %	1,3 %	1.00
	Suicide	0,0 %	0,0 %	0,0 %	-
	TCA	5,2 %	0,0 %	6,3 %	0.58
	Dépression	19,8 %	23,5 %	19,0 %	0.74
	Troubles anxieux	6,3 %	5,9 %	6,3 %	1.00
	Troubles de la personnalité	9,4 %	5,9 %	10,1 %	1.00
	Alcoolisme	14,6 %	0,0 %	17,7 %	0.07

Tableau 3. Comparaison des antécédents psychiatriques familiaux dans les deux groupes